中医药整体证据研究的标准化操作规程

项目编号：

编制说明

公示材料

提出单位：广东省中医院、澳大利亚皇家墨尔本理工大学

归口单位：中华中医药学会

项目承担单位：广东省中医院

项目组成员：卢传坚、薛长利、郭新峰、张林、温泽淮、刘少南、Brian May、谢雁鸣、王拥军、商洪才、杨丽虹、Meaghan Coyle、李慧、陈婧、Johanna Shergis、谢秀丽、Claire Zhang、何怡瀚、Yuan Ming DI、赖佳琪

二〇一八年五月

目录

一、工作简况 3
二、标准的主要内容 6
三、采用国际标准的程度及水平 9
四、重大意见的处理经过和依据 9
五、贯彻团体标准的要求和措施建议 9
六、废止现有有关标准的建议 9
附件 1 文献调研总结 10
附件 2 11
《中医药整体证据研究的标准化操作规程》专家论证会 1 11
《中医药整体证据研究的标准化操作规程》专家论证会 2 12
附件 3 13
《中医药整体证据研究的标准化操作规程》同行征求意见总结 1 13
《中医药整体证据研究的标准化操作规程》同行征求意见总结 2 13

公示材料

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》项目由中华中医药学会批准立项，广东省中医院承担，由广东省中医院和澳大利亚皇家墨尔本理工大学一起承担起草，中国中医科学院中医临床基础医学研究所、上海中医药大学、北京中医药大学东直门医院参与起草，项目成立专家指导组和项目工作组。项目工作组按照国家团体标准的编写规则和要求，通过文献调研、专家咨询、专家论证、同行征求意见等环节，完成了起草工作，形成了《中医药整体证据研究的标准化操作规程》的送审稿，现就《中医药整体证据研究的标准化操作规程》的编制情况作如下说明。

一、工作简况

（一）任务来源，协作单位

2017 年 6 月中华中医药学会批准立项团体标准《中医药整体证据研究的标准化操作规程》，项目承担单位及主要完成单位是广东省中医院，项目负责人卢传坚，协作单位是澳大利亚皇家墨尔本理工大学（RMIT），参与起草为中国中医科学院中医临床基础医学研究所、上海中医药大学、北京中医药大学东直门医院，由中华中医药学会标准化专家组负责技术指导和项目督导。

（二）主要工作过程

1. 成立内部专家组与工作组

按照标准工作程序要求，成立内部专家组与工作组：

专家组：

广东省中医院：卢传坚、郭新峰、温泽淮、李慧

RMIT：薛长利、张林、Brian May,、Meaghan Coyle

中国中医科学院中医临床基础医学研究所：谢雁鸣

上海中医药大学：王拥军

北京中医药大学东直门医院：商洪才

工作组：

公示材料

广东省中医院:刘少南、杨丽虹、陈婧、何怡瀚、谢秀丽、赖佳琪

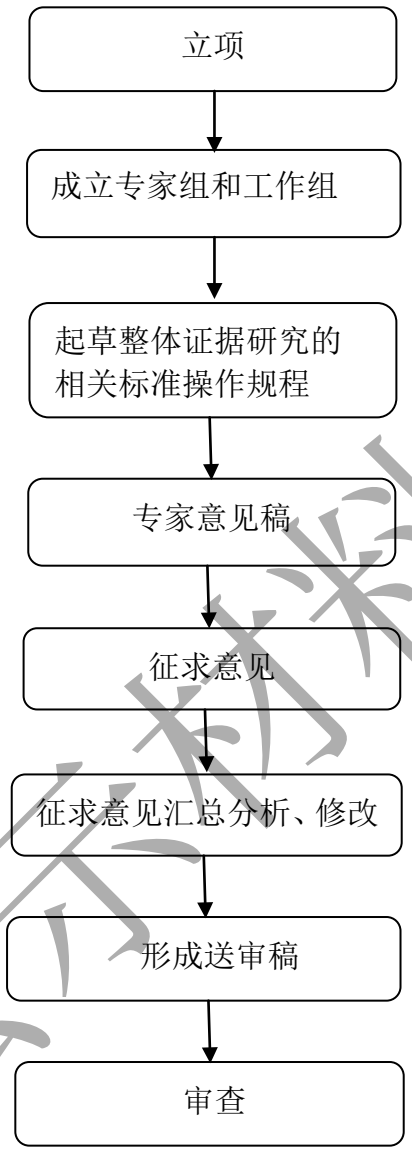
RMIT: Johanna Shergis, Claire Zhang, Yuan Ming DI

2. 起草相关的标准操作规程

2017 年 8 月，项目组组织开展了整体证据相关的文献调研工作，根据文献调研结果，2017 年 11 月项目组内部进行了广泛讨论和共识，确定主要的标准操作规程包括现代文献和古籍检索词的确定、中英文数据库的检索策略、古籍数据库的检索策略、文献的筛选和编码流程、数据的提取、数据管理软件的操作、现代文献的偏倚评估、统计分析以及证据评价工具的应用等，同时规范 SOP 的格式以及版权声明等。项目工作组根据共识结果，撰写了标准初稿，2018 年邀请临床专家、方法学专家及标准化工作组专家对标准的初稿进行了两次论证，根据专家意见对标准进行了修改和完善，形成了《中医药整体证据研究的标准化操作规程》的征求意见稿。2019 年 4 月向全国 7 家单位发送征求意见稿 7 份，收回 7 份，提出相关问题 15 条，工作组充分讨论了专家提出的意见，并提出了采纳、不采纳的意见和理由，其中专家提出根据内容分成三个独立的部分更能清晰的呈现本标准的内容，针对性和操作性更强，工作组将反馈意见上报中华中医药学会标准化办公室，办公室专家讨论后反馈同意将本标准分为三个标准进行编写，项目工作组对标准进行了进一步的修改完善，最终形成了《中医药整体证据研究的标准化操作规程》送审稿。2019 年 11 月 15 日，工作组将本标准的送审稿上交至学会进行形式审查。2019 年 12 月 4 日，学会反馈团体标准形式审查意见，工作组根据意见进行修改完善，扩大范围征求专家意见。2019 年 12 月工作组进一步增加征求单位 10 家，发放征求意见稿 10 份，收回 10 份，提出相关问题 48 条，工作组充分讨论了专家提出的意见，并提出了采纳、不采纳的意见和理由，并进一步完善了《中医药整体证据研究的标准化操作规程》送审稿。2020 年 3 月，学会组织专家对本标准进行函审，标准通过专家的审查。

公示材料

具体的操作技术路线图如下：



公示材料

（三）标准主要起草人及其所作工作

姓名	学位	职称	所在单位	工作内容
卢传坚	博士	教授	广东省中医院	参与起草及论证

薛长利	博士	教授	RMIT	参与起草及论证
郭新峰	博士	研究员	广东省中医院	参与起草及论证
张林	博士	副教授	RMIT	参与起草及论证
温泽淮	博士	研究员	广东省中医院	参与起草及论证
刘少南	硕士	助理研究员	广东省中医院	部分内容起草
Brian May	博士		RMIT	部分内容起草
谢雁鸣	博士	教授	中国中医科学院中医临床基础医学研究所	参与起草及论证
王拥军	博士	教授	上海中医药大学	参与起草及论证
商洪才	博士	教授	北京中医药大学东直门医院	参与起草及论证
杨丽虹	硕士	主治医师	广东省中医院	部分内容起草
Meaghan Coyle	博士		RMIT	部分内容起草
李慧	博士	主任医师	广东省中医院	参与起草及论证
陈婧	硕士	研究实习员	广东省中医院	部分内容起草
Johanna Shergis	博士		RMIT	部分内容起草
谢秀丽	博士	主治医师	广东省中医院	部分内容起草
Claire Zhang	博士		RMIT	部分内容起草
何怡瀚	硕士	研究实习员	广东省中医院	部分内容起草
Yuan Ming DI	博士		RMIT	部分内容起草
赖佳琪	学士		广东省中医院	部分内容起草

公示材料

二、标准的主要内容

1.标准的主要内容及框架

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》共分为三个部分：总则、古籍证据梳理的标准化操作规程、现代研究证据梳理的标准化操作规程。每一部分按照具体内容分为范围、规范性引用文件、术语和定义、具体的操作步骤、附录组成。

第一部分总则系统介绍了中医药整体证据研究的指导原则，中医药整体证据的基本内容包括中医或中西医指南、教科书及专著关于中医对疾病病因病机、辨诊断、治疗等认识的证据、中医古籍对疾病认识的证据、现代研究中中医或中西医治疗疾病的证据、临床前实验室药理研究的证据以及整体证据的汇总和推荐。

第二部分介绍了中医古籍证据梳理的系统方法，包括：

（1）疾病相关古籍检索词的确定（包括古籍病名、症状和体征相应的检索词）

（2）古籍条文的纳入排除标准

（3）《中华医典》第五版的检索

（4）古籍数据的处理

1） 结果的导出

2） 条文除重

3） 数据编码

（5）古籍数据的分析

第三部分系统介绍了现代研究证据的梳理方法以及中医药整体证据的汇总和推荐，具体包括：

（1）现有中、西医指南、专著及教科书对疾病认识的梳理内容和方法

（2）现代临床研究的证据梳理方法

1） 中英文检索词的确定

2） 中英文数据库的具体检索方法

3） 文献管理软件 EndNote 的具体操作

公示材料

4） 现代研究数据的编码和提取

5） 现代研究偏倚风险的评价和证据水平的总结

6） 临床前实验室药理研究证据的梳理和汇总

7） 中医药整体证据的汇总和推荐

2.标准的专家论证过程

标准化操作规程草稿形成后，2018 年 3 月邀请方法学、临床专家、广东省中医院标准化专家及项目组成员对草稿内容进行论证，讨论确定了中医药整体证据标准化操作规程具体涵盖的内容以及具体内容操作方法的呈现形式，特别强调了操作规程描述的规范性和可操作性，专家提出很多有价值的修改意见。项目工作组在前期专家意见的基础上，进行了多轮的修订，2018 年 10 月在广州邀请相关专家，进行了进一步的论证，经过反馈修改形成了最终的征求意见稿。

详见附件 2：《中医药整体证据研究的标准化操作规程》专家论证会

3.同行评议情况

项目工作组于 2019 年 4 月起共邀请了 7 位专家对本标准操作规程进行了同行评价，邀请的专家均是中医药领域内承担过相关科研项目，并在中医药循证医学领域内具有较高学术造诣和影响力。截止 2019 年 10 月，共发放征求意见表 7 份，收回 7 份，提出相关问题 15 条，工作组讨论了专家们的意见，并提出了采纳、不采纳的意见和理由。2019 年 11 月送审稿提交学会，反馈需扩大征求专家范围，项目工作组于 2019 年 12 月起继续邀请了 10 位专家对本标准操作规程进行了同行评价，截止 2020 年 3 月，共发放征求意见表 10 份，收回 10 份，提出相关问题 48 条，专家均表示该操作规程内容详细具体、可操作性强，值得推广应用。工作组充分讨论了专家提出的意见，并提出了采纳、不采纳的意见和理由，并对本操作规程进行了修改。

详见附件 3：《中医药整体证据研究的标准化操作规程》同行征求意见总结

公示材料

三、采用国际标准的程度及水平

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》中现代研究的证据梳理方法,是采取目前国际上公认的系统评价方法全面的梳理中医药现代研究证据,选择了制作系统评价最公认常用的中英文数据库，采用 Cochrane 偏倚风险评估工具分析研究存在的潜在偏倚，同时应用包括 WHO 在内多个国家或学术组织公认的 GRADE 证据分级系统对中医药证据进行评价，在中医药领域处于领先水平。

四、重大意见的处理经过和依据

在本标准制作过程中，既结合前期具体研究病种形成的经验，同时应用在做的病种验证本标准制定过程的操作细节，针对存在的难点和难以解决的问题，及时的在项目组内讨论，必要的进行专家咨询或共识讨论决定。编制形成的标准初稿,及时征询全国同领域专家的意见。特别是专家对本标准结构框架修改的建议，咨询中华中医药学会标准化办公室专家的意见,在符合标准制定基本原则的前提下，接纳专家意见，对标准的内容框架进行了调整，使本标准的内容结构上更加的清晰，针对性和操作性更强，更利于标准的推广应用。具体的同行评议意见见附件 3。

五、贯彻团体标准的要求和措施建议

本标准经批准发布实施后,建议有针对性地开展中医药整体证据研究方法的宣传和集中培训，通过标准的实施、宣传和不断的改进与更新，使标准得到有效的应用，促进中医药整体证据研究的标准化，进而推动中医药实践指南的发展。

六、废止现有有关标准的建议

本标准没有涉及废止现行有关标准。

附件 1 文献调研总结

附件 2《中医药整体证据研究的标准化操作规程》专家论证会

附件 3《中医药整体证据研究的标准化操作规程》同行征求意见总结

公示材料

附件 1 文献调研总结

内容：中医药现代研究、古籍等整体证据研究方法及梳理现状

检索词：中医药、整体证据、多来源证据、证据体、系统评价及相关英文

年代范围：数据库建库至 2017 年

选用数据库：中国知网、中国生物医学文献数据库、PubMed、EMBASE、Cochrane Library

文献调研结果总结：

1.目前关于中医药整体证据的系统研究尚属空白，多是基于现代临床研究的证据总结，目前采用较多的方法是 Cochrane library 推荐的系统评价和 meta 分析方法，本项目针对于临床研究的证据总结可借鉴此方法，结合中医药特点优化完善相关方法学和具体的操作步骤。

2.关于证据体的研究，多是基于多来源证据的证据评价分级的考虑，国内学者提出古籍证据的特殊性，完全按照现代临床科研的工具评价并不恰当，并针对中医药特点，在证据评价方面进行了积极的探索。目前国际上较公认的证据评价方法是 GRADE 工作组提出的证据分级方法，本项目考虑针对现代临床研究应用 GRADE 评价方法，并考虑古籍特点进行进一步探索。

3.目前关于古籍的探索和评价相对较分散，未形成一套系统、高效的梳理和评价方法，《中华医典》作为目前古籍收录较广泛、操作智能便捷的光盘数据库，具有较大的优势，本项目基于此数据库，探索相关的梳理评价方法，有利于古籍证据的系统高效梳理和推广应用。

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》项目工作组

2017 年 10 月

公示材料

附件 2

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》专家论证会 1

会议时间：2018 年 3 月 1 日

会议地点：广东省中医院

参会专家：薛长利、张林、谢雁鸣、商洪才、王拥军、温泽淮、郭新峰、李慧、林琳、毛炜、张海波、李云英、吕渭辉、黄绍刚、吴蕾

项目组组长：卢传坚，秘书：刘少南

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》项目工作组组长卢传坚教授向各位专家介绍了项目的背景及工作情况，与会的专家对团体标准的重要性和必要性给予了充分的肯定，针对草稿中的具体细节展开了详细的讨论，基本上达成了共识，提出了具体的修改意见，细节如下：

1.关于证据总结表的形式，弱化证据评价细节，直接显示证据等级，突出中医疗法相对于对照组的相对或绝对的效应。

2.基于光盘版的古籍的检索和导出相对繁琐耗时，及时跟进《中华医典》的更新工作，并更新相关的操作细则，保证古籍文献的高效整理。

3.具体的文献偏倚评估方法，在遵循国际原则的情况下，结合中文文献的特点做适当调整，保证操作性更强和评价的一致性

4.针对于现代研究文献，不同研究类型的证据强度不同，关于整体证据的梳理评价，应有所侧重，重点突出随机对照试验的证据。

5.标准的格式书写不够规范，应参照中华中医药学会的标准要求进行详细修改。

专家们认为《中医药整体证据研究的标准化操作规程》是基于中医药优势病种的系统研究总结的具体实施细节，并在一系列病种进行了应用，可操作性强，可针对专家们提出的意见进行完善修改，形成《中医药整体证据研究的标准化操

公示材料

作规程》的征求意见稿，在全国中医药医疗机构、科研及教育机构等广泛征求意见。

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》项目工作组

2018 年 3 月 1 日

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》专家论证会 2

会议时间：2018 年 10 月 10 日

会议地点：广东省中医院

参会专家：吕爱平、商洪才、刘新灿、薛长利、张林、谢雁鸣、王拥军、温泽淮、郭新峰、李慧、林琳、毛炜

项目组组长：卢传坚，秘书：刘少南

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》项目工作组组长卢传坚教授向各位专家汇报了本项目组的工作情况，并强调了前一次专家论证会后所作的修订工作，专家们积极发言、认真讨论，对标准的主题内容基本达成了共识，并提出了部分修改意见，主要包括：

1.关于标准的操作规程的表述，应该兼顾专业性和可读性两方面，应用通俗的语言将核心的方法阐述透彻，以利于标准的理解、推广和应用。

2.关于古籍的数据分析，可考虑增加关联规则等进一步的深入分析，充分挖掘古籍宝库，体现中医药的传承创新。

3.“我们”这些口语化的字眼不宜出现在标准汇总，应予去除。

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》项目工作组

2018 年 10 月 10 日

公示材料

附件 3

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》同行征求意见总结 1

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》项目工作组于 2019 年 4 月向全国中医药领域内承担过相关科研项目，并在中医药循证医学领域内具有较高学术造诣和影响力的专家发放征求意见表。调查单位包括：广东省中医院、广州中医药大学、河南中医药大学第一附属医院、天津中医药大学、江西中医药大学、温州医科大学附属第二医院、北京中医药大学。调查专家如下：刘建平、吴大嵘、刘新灿、王泓午、陈晓凡、郑国庆、王奇。

截止 10 月 20 日，共发放征求意见表 7 份，收回 7 份，提出相关问题 15 条，工作组充分讨论了专家提出的意见，并提出了采纳、不采纳的意见和理由，并对标准进行了修改。

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》工作组

2019 年 10 月 26 日

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》同行征求意见总结 2

2019 年 12 月，中华中医药学会形式审查意见提出扩大专家征求意见范围，项目组于 2019 年 12 月进一步调查单位包括：中国中医科学院西苑医院、香港浸会大学、兰州大学、复旦大学附属静安区中心医院、广西中医药大学、首都医科大学附属北京中医医院、香港中文大学、北京中医药大学东直门医院、上海中医药大学、四川大学华西医院。调查专家如下：陈可冀、吕爱平、陈耀龙、张天嵩、郑景辉、李博、钟志豪、唐雪春、邓宏勇、李玲。

截止 2020 年 3 月 10 日，共发放征求意见表 10 份，收回 10 份，提出相关问题 48 条，工作组充分讨论了专家提出的意见，并提出了采纳、不采纳的意见和理由，并对标准进行了修改。

《中医药整体证据研究的标准化操作规程》工作组

2020 年 3 月 12 日

公示材料